

Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório e Patologias Relacionadas

Disciplina: Assistência de Enfermagem nas Patologias Cardiovasculares, Respiratórias e Endócrinas – Proz Educação

1. Leia atentamente todas as questões antes de responder.
2. Cada questão objetiva possui apenas uma alternativa correta; marque-a com clareza.
3. As questões discursivas (casos clínicos) devem ser respondidas de forma clara, completa e fundamentada teoricamente.
4. Não é permitida a utilização de celular, anotações ou qualquer material de consulta durante a realização do simulado.
5. Ao concluir, revise todas as respostas antes de entregar o simulado.

QUESTÕES OBJETIVAS

(VUNESP – Técnico em Enfermagem – adaptada)

1. O trato respiratório é dividido em superior e inferior conforme a localização anatômica de seus órgãos. Compõem o trato respiratório superior:

- A) Esôfago, estômago e cavidade oral.
- B) Traqueia inferior, brônquios, bronquíolos e alvéolos.
- C) Bronquíolos, alvéolos, pleura e diafragma.
- D) Pulmões, mediastino e músculos intercostais.
- E) Cavidade nasal, faringe, laringe e a parte superior da traqueia.

(FCC – Técnico em Enfermagem – adaptada)

2. A faringe é um tubo de aproximadamente 15 cm que participa tanto do sistema respiratório quanto do digestório. Sua porção intermediária, localizada atrás da cavidade oral e responsável por conduzir tanto o ar quanto os alimentos, é denominada:

- A) Nasofaringe.
- B) Laringofaringe.
- C) Orofaringe.
- D) Epiglote.
- E) Glote.

(IBFC – Técnico em Enfermagem – adaptada)

3. A laringe desempenha diversas funções no organismo. Entre elas, destaca-se a de impedir a passagem de alimentos e outras substâncias para os pulmões, função exercida especificamente pela:

- A) Traqueia.
- B) Epiglote.
- C) Úvula palatina.
- D) Cartilagem cricoide.
- E) Membrana pleural.

(AOCP – Técnico em Enfermagem – adaptada)

4. A traqueia é um tubo cilíndrico e oco, de aproximadamente 12 cm de comprimento, cuja estrutura apresenta uma característica fundamental para a manutenção da via aérea. Essa característica é a presença de:

- A) Cílios musculares contráteis que impulsionam o ar em direção aos alvéolos.
- B) Uma dupla camada de membrana serosa semelhante à pleura.
- C) Válvulas unidirecionais que impedem o refluxo de ar durante a expiração.
- D) De 16 a 20 anéis de cartilagem, que impedem o colapso de suas paredes.
- E) Tecido cartilaginoso maciço e contínuo, sem qualquer flexibilidade.

(QUADRIX – Técnico em Enfermagem – adaptada)

5. A hematose, processo essencial para a manutenção da vida, ocorre especificamente:

- A) Nos alvéolos pulmonares, onde o sangue libera gás carbônico e recebe oxigênio.
- B) Nos bronquíolos terminais, antes da chegada do ar aos alvéolos.
- C) Na cavidade nasal, durante o aquecimento e a filtração do ar inspirado.
- D) Na traqueia, por meio da difusão através dos anéis cartilagosos.
- E) No mediastino, espaço situado entre os dois pulmões.

(CESPE/CEBRASPE – Técnico em Enfermagem – adaptada)

6. A respeito da anatomia dos pulmões, é correto afirmar que:

- A) Ambos os pulmões possuem três lobos e dimensões idênticas.
- B) O pulmão esquerdo é maior e possui três lobos, enquanto o direito possui dois.
- C) O pulmão direito é maior e dividido em três lobos por duas fissuras, enquanto o esquerdo é menor, devido ao espaço ocupado pelo coração, e dividido em dois lobos por uma fissura.
- D) Os pulmões não apresentam divisão em lobos, sendo estruturas contínuas.
- E) Os pulmões estão localizados no interior do mediastino anterior.

(VUNESP – Técnico em Enfermagem – adaptada)

7. A pleura é a membrana que reveste e protege os pulmões, sendo formada por dois folhetos. Sobre eles, é correto afirmar que:

- A) Os folhetos pleurais são responsáveis pela produção do surfactante alveolar.
- B) O folheto parietal reveste diretamente a superfície do pulmão, e o visceral, a parede torácica.
- C) Ambos os folhetos revestem exclusivamente a superfície do diafragma.
- D) A pleura é formada por um único folheto, que envolve os dois pulmões simultaneamente.
- E) O folheto visceral reveste a superfície do pulmão, e o parietal está em contato com o diafragma e com a borda interna do tórax.

(FEPESE – Técnico em Enfermagem – adaptada)

8. O diafragma é o principal músculo envolvido na mecânica ventilatória. Quanto ao seu funcionamento, é correto afirmar que ele:

- A) Contrai-se durante a inspiração e relaxa durante a expiração.
- B) Permanece imóvel durante todo o ciclo respiratório.
- C) Contrai-se durante a expiração e relaxa durante a inspiração.
- D) Separa a cavidade torácica da cavidade craniana.
- E) Atua apenas durante a respiração forçada, não participando da respiração basal.

(FCC – Técnico em Enfermagem – adaptada)

9. A asma é definida como:

- A) Infecção aguda que provoca inflamação dos alvéolos pulmonares.
- B) Acúmulo de líquido nos tecidos e alvéolos pulmonares, com hipoxemia.
- C) Obstrução de ramo da artéria pulmonar por coágulo proveniente do sistema venoso profundo.
- D) Doença inflamatória crônica que acomete principalmente os brônquios, com hiperresponsividade das vias aéreas e obstrução reversível do fluxo aéreo.
- E) Destruição irreversível das paredes alveolares com perda de elasticidade pulmonar.

(IBFC – Técnico em Enfermagem – adaptada)

10. Constituem manifestações clínicas típicas da asma:

- A) Febre alta, escarro purulento e dor pleurítica.
- B) Dispneia, sibilância, tosse geralmente seca e sensação de aperto torácico.
- C) Expectoração rósea espumosa, turgência de jugular e ortopneia.
- D) Perda de peso acentuada, deformidades ungueais e letargia.
- E) Hemoptise volumosa, icterícia e distensão abdominal.

(AOCP – Técnico em Enfermagem – adaptada)

11. Durante a avaliação de um paciente asmático, são considerados sinais de gravidade indicativos de crise asmática:

- A) Frequência cardíaca inferior a 60 bpm e frequência respiratória de 12 irpm.
- B) Ausência completa de sintomas entre as crises, sem outros achados.
- C) Taquicardia acima de 120 bpm, taquipneia acima de 30 irpm, tiragens intercostais, uso de musculatura acessória, batimento de aleta nasal, cianose e rebaixamento do nível de consciência.
- D) Elevação isolada da temperatura corporal, sem alteração respiratória.
- E) Presença de murmúrio vesicular aumentado de forma difusa e simétrica.

(QUADRIX – Técnico em Enfermagem – adaptada)

12. No tratamento da asma, são utilizados medicamentos de alívio com efeito broncodilatador, que atuam relaxando a musculatura dos brônquios. São exemplos desses fármacos:

- A) Furosemida e espironolactona.
- B) Heparina e varfarina.
- C) Omeprazol e ranitidina.
- D) Paracetamol e dipirona sódica.
- E) Salbutamol, ipratrópio e fenoterol.

(CESPE/CEBRASPE – Técnico em Enfermagem – adaptada)

13. A bronquite crônica caracteriza-se por processo inflamatório crônico dos brônquios, geralmente secundário ao uso do tabaco ou a processo alérgico, sendo também classificada como:

- A) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- B) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA).
- C) Pneumonia adquirida na comunidade.
- D) Tromboembolismo venoso recorrente.
- E) Edema agudo de pulmão não cardiogênico.

(VUNESP – Técnico em Enfermagem – adaptada)

14. A pneumonia é uma infecção que provoca inflamação dos alvéolos pulmonares. Quanto à sua classificação, define-se como pneumonia adquirida no hospital aquela que:

- A) Ocorre na comunidade ou em até 48 horas após a internação hospitalar.
- B) Se manifesta após 48 horas da admissão, em paciente que não apresentava sintomas na entrada.
- C) Acomete paciente não hospitalizado, porém em cuidado domiciliar.
- D) Se manifesta apenas após a alta hospitalar, independentemente do tempo decorrido.
- E) Manifesta-se a partir de 48 horas após a intubação e o uso de ventilação mecânica.

(FEPESE – Técnico em Enfermagem – adaptada)

15. São complicações possíveis do quadro de pneumonia:

- A) Diabetes mellitus tipo 1 e hipotireoidismo congênito.
- B) Hipertensão arterial sistêmica primária e dislipidemia.
- C) Cálculo renal e infecção do trato urinário.
- D) Choque, insuficiência respiratória grave, derrame pleural, empiema e Síndrome da Angústia Respiratória Aguda.
- E) Fratura de arcos costais e pneumotórax traumático.

(FCC – Técnico em Enfermagem – adaptada)

16. Entre os cuidados de enfermagem ao paciente com pneumonia, é fundamental observar e comunicar sinais de choque séptico, tais como:

- A) Queda da temperatura corporal abaixo do normal, hipotensão e diminuição do nível de consciência.
- B) Aumento do apetite e ganho rápido de peso corporal.
- C) Elevação isolada da saturação de oxigênio acima de 98%.
- D) Hipertensão arterial sustentada e bradicardia acentuada.
- E) Redução da frequência respiratória para valores abaixo de 10 irpm sem outras alterações.

(IBFC – Técnico em Enfermagem – adaptada)

17. O enfisema pulmonar é uma doença pulmonar obstrutiva crônica caracterizada pela dilatação dos espaços aéreos ou destruição da parede alveolar, com perda da elasticidade pulmonar. Sua principal causa é:

- A) A infecção bacteriana de repetição das vias aéreas superiores.
- B) A exposição ocupacional exclusiva a ruídos intensos.
- C) O tabagismo.
- D) A reação alérgica a alimentos como leite e ovos.
- E) A imobilização prolongada no leito.

(AOCP – Técnico em Enfermagem – adaptada)

18. Ao assistir um paciente com enfisema pulmonar, o técnico de enfermagem deve observar a ocorrência de sonolência excessiva, inquietação, agressividade, cefaleia e vertigem, pois esses achados indicam:

- A) Efeito colateral esperado e transitório dos broncodilatadores.
- B) Melhora progressiva da ventilação e da troca gasosa.
- C) Reação alérgica local ao dispositivo de oxigenoterapia.
- D) Resposta fisiológica normal ao decúbito elevado.
- E) Sinais de sofrimento cerebral decorrente da falta de oxigênio.

(QUADRIX – Técnico em Enfermagem – adaptada)

19. O edema agudo de pulmão (EAP) é uma situação de emergência caracterizada pelo acúmulo de líquidos nos tecidos e alvéolos pulmonares, resultando em hipoxemia. Um sinal clássico desse quadro é:

- A) A febre alta persistente com calafrios intensos.
- B) A expectoração rósea espumosa, associada aos demais sintomas.
- C) A hemoptise volumosa de início súbito.
- D) A ausência completa de esforço respiratório.
- E) O escarro purulento de coloração esverdeada.

(CESPE/CEBRASPE – Técnico em Enfermagem – adaptada)

20. Entre os cuidados de enfermagem prestados ao paciente com edema agudo de pulmão consciente, inclui-se mantê-lo sentado, com os membros inferiores fletidos ou pendentes, com a finalidade de:

- A) Aumentar o retorno venoso ao coração e elevar a pressão arterial.
- B) Facilitar a coleta de exames laboratoriais de urgência.
- C) Prevenir a formação de úlceras por pressão nos calcâneos.
- D) Reduzir o retorno venoso e, conseqüentemente, a congestão pulmonar.
- E) Estimular o aumento da frequência respiratória do paciente.

CASOS CLÍNICOS

Caso Clínico 1

Um adolescente de 15 anos chega à unidade de emergência acompanhado da mãe, apresentando dificuldade para respirar iniciada após atividade física em ambiente com muita poeira. Ao exame, apresenta chiado no peito à expiração, expiração prolongada, tosse seca e frequência respiratória de 32 incursões por minuto. Refere episódios semelhantes anteriores, permanecendo bem entre eles.

Identifique a principal hipótese diagnóstica e descreva os cuidados de enfermagem indicados para esse paciente.

Caso Clínico 2

Uma senhora de 70 anos é internada com febre alta, tosse produtiva com escarro purulento, taquipneia, dor torácica que piora à inspiração profunda e falta de apetite. No segundo dia de internação, a equipe observa queda da temperatura corporal abaixo do normal, hipotensão arterial e sonolência progressiva.

Explique qual complicação está sendo sugerida por essa mudança no quadro clínico e qual deve ser a conduta imediata da equipe de enfermagem.

Caso Clínico 3

Um homem de 66 anos, tabagista há mais de quarenta anos, procura atendimento com queixa de tosse com grande quantidade de catarro, chiado constante no peito, falta de ar progressiva, perda de peso sem causa aparente e deformidades nas unhas.

Identifique a patologia mais provável, explique sua relação com o histórico do paciente e indique a medida mais importante para reduzir a progressão da doença.

Caso Clínico 4

Um paciente de 74 anos, com antecedente de infarto agudo do miocárdio, é admitido na emergência com dispneia intensa, ortopneia, sudorese, palidez, cianose de extremidades, turgência de jugular e expectoração rósea espumosa. Encontra-se consciente, porém agitado e referindo sensação de afogamento.

Identifique o quadro apresentado, classifique-o quanto à sua origem e descreva os cuidados de enfermagem imediatos.

Caso Clínico 5

Uma paciente de 58 anos, obesa, encontra-se imobilizada no leito há vários dias após cirurgia de grande porte. Subitamente, passa a apresentar dispneia de início abrupto e dor torácica do tipo pleurítica, que piora com a respiração profunda.

Explique a principal hipótese diagnóstica para esse quadro, relacionando-a aos fatores de risco apresentados pela paciente.

❖ MENSAGEM DO PROFESSOR ❖

Respirar é a única coisa que o corpo faz sem parar desde o primeiro segundo de vida, e é também a primeira que ele perde quando algo vai mal. Por isso a enfermagem olha para o tórax antes de olhar para qualquer exame: no chiado, na tiragem, no batimento da asa do nariz, o corpo pede socorro em uma linguagem que só quem estudou consegue ler. Aprenda essa linguagem. Enquanto houver quem saiba escutá-la, ninguém ficará sem ar sozinho.

Prof. Alexandre G. S. Cruz | Enfermeiro